

보건복지부 고시 제2026-92호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2026-69호(2026. 3. 26.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 4월 22일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정(안)

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[122] suxamethonium chloride 주사제(품명: 타케다리스테논주), [217] Verapamil HCl 주사제(품명: 비아트리스이숍틴주), [218] cholestyramine resin 경구제(품명: 에픽콜레스티라민현탁용산(라이트)4그램 등), [241] Somapacitan 주사제(품명: 소그로야프리필드펜), [399] Oxitriptan 경구제(품명: 센라5-에이치티피캡슐)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 당뇨병용제, [일반원칙] 흡입마취에 사용되는 약제, [142] Dupilumab 주사제(품명: 듀피젠트프리필드주300밀리그램 등), [219] 고혈압치료제 + 고지혈증 치료제 복합경구제, [229] Benralizumab 주사제(품명: 파센라프리필드시린지주30밀리그램), [229] Mepolizumab 주사제(품명: 누칼라주), [229] Reslizumab 주사제(품명: 싱케어주), [232] Sulglycotide 경구제(품명: 글립타이드정 200밀리그램), [241] Somatrogon 주사제(성장호르몬제)(품명: 엔젤라프리필드펜주 24mg 등)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 5월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[122] 골격근이완제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[122] suxamethonium chloride 주사제 (품명: 타케다리스테논주)	<신 설>	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위: 1) 전신 마취 중 기관내 삽관을 위한 근이완제 2) 전기경련요법(ECT)시 경련완화	○ 미허가 긴급도입의약품인 ‘타케다리스테논주’가 신규 등재 예정임에 따라 식품의약품안전처장이 인정하는 범위 내에서 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 신설>			

[217] 혈관확장제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[217]	<신 설>	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를	○ 미허가 긴급도입의약품인

Verapamil HCl 주사제 (품명: 비아트리스이슈틴주)	인정함. - 아 래 - ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위: 협심증, 부정맥	‘비아트리스이슈틴주’가 신규 등재 예정임에 따라 식품의약품안전 처장이 인정하는 범위 내에서 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 신설>		

[218] 동맥경화용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[218] cholestyramine resin 경구제 (품명: 에픽콜레스티라민 현탁용산 (라이트)4그램 등)	<신 설>	식품의약품안전처장이 인정한 범위 및 [일반원칙] 고지혈증치료제 “세부사항” 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 혈청 콜레스테롤 수치 감소 ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위: 1) 혈청콜레스테롤 수치 감소	○ 미허가 긴급도입의약품인 ‘에픽콜레스티라민현탁용산(라이트)4그램’과 ‘에픽콜레스티라민현탁용산4그램’이 신규 등재 예정임에 따라 급여기준을 신설함. 다만, 식품의약품안전처장이 인정하는 범위 내에서

		2) 부분적 담도폐쇄에 의한 가려움증 3) 관상동맥죽상경화증 진행 속도 감소	‘혈청 콜레스테롤 수치 감소’로 제한함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 신설>			

[241] 뇌하수체호르몬제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사 유
	현 행	개 정(안)	
[241] Somapacitan 주사제 (품명: 소그로야프리필드펜)	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1) 소아성장호르몬결핍증 가) 소아성장호르몬결핍증 (1) 투여대상 (가) 해당 역연령의 3퍼센타일 이하의 신장이면서 (나) 2가지 이상 성장호르몬 유발검사로 확진되고 (다) 해당 역연령보다 골연령이 감소된 자 (2) 투여용량 : ○ 주당 0.16mg/kg (3) 투여기간 ○ 역연령 만 3세 이상부터 골단이 닫히기 전까지 투여하나 골연령이 여자의 경우 14-15세, 남자의 경우 15-16세 범위 내에서 급여하고, 동 범주 내에	○ ‘Somapacitan 주사제’가 신규 등재 예정임에 따라 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 및 전문가의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함

		포함되지만 현재 신장이 여자의 경우 153cm, 남자의 경우 165cm 초과되는 자는 전액 본인 부담함. 나) 기질적인 원인으로 인하여 뇌하수체 기능이 저하된 경우(예 : 뇌하수체절제술, 방사선 치료 등) (1) 투여대상 (가) 뇌하수체절제술을 시행한 경우 : 1가지 이상 성장호르몬 유발검사로 확진된 자 (나) 방사선 치료 등으로 인한 뇌하수체기능이 저하된 경우 : 2가지 이상 성장호르몬 유발검사로 확진된 자 (2) 투여용량 ○ 키가 크더라도 성장판이 닫힐 때까지는 전체 용량(Full dose), 그 다음엔 성인성장호르몬결핍증 치료용량으로 인정 (3) 투여기간 ○ 골단이 닫히기 전까지 투여하나 골연령이 여자의 경우 14-15세, 남자의 경우 15-16세 범위 내에서 급여하고, 동 범주 내에 포함되지만 현재 신장이 여자의 경우 153cm, 남자의 경우 165cm 초과되는 자는 전액 본인 부담함. 2) 성인성장호르몬결핍증 가) 투여대상 (1) 유년기 개시형 결핍증(Childhood onset) 유년기에 성장호르몬 결핍증으로 진단 받은 환자는 골단이 막혔거나, 역연령 남자 만 18세, 여자 만 16세가 넘어 성장이 거의 끝났다고 판정하였을 때 성장호르몬 대체요법을 시작하기 전에 반드시 재평가를 받아 성장호르몬 결핍증임이 확인되어야 함. (2) 성인기 개시형 결핍증(Adult onset) 성장호르몬 대체요법을 시작하기 전에 시	
--	--	---	--

		상하부 또는 뇌하수체 질환 등에 의한 2차적 성장호르몬 결핍증과 적어도 한 가지 이상의 다른 호르몬 결핍증(프로락틴 제외)이 진단되어야 하며, 적절한 대체요법을 받고 있어야 함. 나) 성장호르몬 결핍증 진단 기준 ○ 성장호르몬 분비 자극검사 [인슐린 부하검사(ITT), GHRH 자극검사, L-dopa 자극검사, Arginine 자극검사, Clonidine 자극검사, 글루카곤(Glucagons)] 중 최소한 2가지 이상의 검사를 시행하여 자극된 최대 혈청 성장호르몬 농도가 5ng/ml(또는 5μg/L) 이하로 진단된 경우 (단, 인슐린 부하검사(ITT)를 한 경우는 1가지 검사만으로도 최대 혈청 성장호르몬 농도가 5ng/ml (또는 5μg/L) 이하이면 인정) 다) 투여용량 ○ 허가사항에 따라 투여(주당 최대 8mg) 라) 투여기간 ○ 3년간 투여 후 다시 자극검사를 시행(기질적 원인에 의한 범뇌하수체 기능저하증으로 확진된 경우는 제외)하여 성장호르몬 결핍이 있으면 연장 가능(투여소견서와 검사결과를 첨부) 마) 효과에 대한 모니터링 ○ 치료시작 후 3개월까지는 최소 2-4주 간격으로 시행한 인슐린양 성장인자-I(IGF-I)의 수치로 성장호르몬의 투여용량의 증감을 결정하며 3개월 이후에는 1-3개월 간격으로 인슐린양 성장인자-I(IGF-I)을 포함한 대사항목을 검사하여 효과에 대한 판정기준으로 함. 2. 장기투여원칙 성장호르몬제를 6개월간 투여해도 별 반응이 없는 환자에 대해서는 진료담당의사는 성장호르몬제 투여의 적정성에 대해 재검토해야 함	
--	--	--	--

		3. 성장호르몬제를 투여할 수 있는 요양기관 조건 1) 반드시 소아과 전문의 또는 내분비학을 전공한 내과전문의가 상근하여야 하며, 가) 성장호르몬제 투여에 관련된 여러 가지 검사(예 : 성장호르몬 유발검사 및 염색체검사 등)를 실시할 수 있는 인력, 시설 및 장비를 갖추고 자체 검사하여 진단·처방시 인정함을 원칙으로 함 나) 방사면역측정법(RIA)에 의한 검사 등은 검체검사위탁에 관한 기준 제3조(수탁기관의 인력 등 기준)에 적합한 기관에 의뢰하여 진단·처방한 경우에도 인정함 2) 최초 진단·처방한 요양기관에서 추적관리 하면서 약제처방만 의원에서 받는 경우는 인정 4. 성장호르몬제는 자가주사로 처방 가능함.	
※ 관련근거 • Williams Textbook of Endocrinology, 15th Edition 2025 • Nelson Textbook of Pediatrics 22nd Edition 2025 • Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th Edition 2023 • 2025 Long-Acting Growth Hormone Therapy in Pediatric Growth Hormone Deficiency: A Consensus Statement • 2019 AACE GROWTH HORMONE TASK FORCE, American Association Of Clinical Endocrinologists And American College Of Endocrinology Guidelines For Management Of growth hormone Deficiency In Adults And Patients Transitioning From Pediatric To Adult Care • 2016 Guidelines for Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor-I Treatment in Children and Adolescents: Growth Hormone Deficiency, Idiopathic Short Stature, and Primary Insulin-Like Growth Factor-I Deficiency • 2020 Diagnosis and Treatment of Growth Hormone Deficiency: A Position Statement from Korean Endocrine Society and Korean Society of Pediatric Endocrinology • L de Fries Jensen et al., Efficacy and Safety of Somapacitan Relative to Somatogon and Lonapegsomatropin in Pediatric Growth Hormone			

Deficiency: Systematic Literature Review and Network Meta analysis. Adv Ther (2024) 41:4098–4124

- BS Miller et al., Weekly Somapacitan is Effective and Well Tolerated in Children With GH Deficiency: The Randomized Phase 3 REAL4 Trial. JCEM, 2022, 107, 3378–3388
- BS Miller et al., Effective GH Replacement With Somapacitan in Children With GHD: REAL4 2-year Results and After Switch From Daily GH. JCEM, 2023, 108, 3090–3099
- BS Miller et al., Efficacy, safety, and insulin-like growth factor I of weekly somapacitan in children with growth hormone deficiency: 3-year results from REAL4. EJE, 2025, 192, 651–661
- G Johannsson et al., Once-weekly Somapacitan is Effective and Well Tolerated in Adults with GH Deficiency: A Randomized Phase 3 Trial. JCEM, April 2020, 105(4):e1358–e1376
- G Johannsson et al., Safety and convenience of once-weekly somapacitan in adult GH deficiency: a 26-week randomized, controlled trial. EJE, (2018) 178, 491–499
- F Otsuka et al., Similar safety and efficacy in previously treated adults with growth hormone deficiency randomized to once-weekly somapacitan or daily growth hormone. Clinical Endocrinology. 2020;93:620–628.
- NICE
- PBAC
- CADTH
- SMC

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[399]	<신 설>	아래와 같이 식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 투여 시 영양급여를 인정함.	○ 미허가 긴급도입의약품인 ‘5-에이치티피캡슐’이

Oxitriptan 경구제 (품명: 센라5-에이치티피 캡슐)		- 아 래 - ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위: BH4 결핍형 페닐케톤뇨증 환자의 치료	신규 등재 예정임에 따라 식품의약품안전처장이 인정하는 범위 내에서 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 신설>			

[별지 2]

[일반원칙] 당뇨병용제					
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유		
	현 행	개 정(안)			
[일반원칙]	(생 략)	(현행과 같음)			
당뇨병용제	※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (생 략) [경구제 중 2제 복합제]	※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (현행과 같음) [경구제 중 2제 복합제]	○ ‘케이글리토징255밀리그램 등 empagliflozin, linagliptin besylate을 주성분으로하는 복합제 4품목이 등재 예정임에 따라, 대상 약제의 ‘경구제 중 2제 복합제’ 중 ‘SGLT-2 inhibitor계+DPP-IV inhibitor계’ 성분군에 해당 성분명을 추가함.		
	성분군	성분명		성분군	성분명
	(생 략)			(현행과 같음)	
	SGLT-2 inhibitor계 +DPP-IV inhibitor계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Gemigliptin, Dapagliflozin+Sitagliptin phosphate, Dapagliflozin+Sitagliptin HCl, Dapagliflozin+Saxagliptin, Dapagliflozin+Evogliptin, Dapagliflozin+Linagliptin, Empagliflozin+Linagliptin, Empagliflozin+Sitagliptin phosphate, Ertugliflozin+Sitagliptin		SGLT-2 inhibitor계 +DPP-IV inhibitor계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Gemigliptin, Dapagliflozin+Sitagliptin phosphate, Dapagliflozin+Sitagliptin HCl, Dapagliflozin+Saxagliptin, Dapagliflozin+Evogliptin, Dapagliflozin+Linagliptin, Empagliflozin+Linagliptin, Empagliflozin+Sitagliptin phosphate, Ertugliflozin+Sitagliptin

[일반원칙] 당뇨병용제				
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)			사유
	현 행		개 정(안)	
	성분군	성분명	성분군	성분명
		phosphate <u><추 가></u>		phosphate <u>empagliflozin+linagliptin</u> <u>besylate</u>
	(생 략)		(현행과 같음)	
	(생 략)		(현행과 같음)	

※ 관련근거
<요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>

[일반원칙] 흡입마취에 사용되는 약제				
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)			사유
	현 행		개 정(안)	
[일반원칙]	흡입마취에 사용되는 약제 중 일부 약제의 요양 급여비용은 아래와 같이 산정하며, 동 사용량을		흡입마취에 사용되는 약제 중 일부 약제의 요양 급여비용은 아래와 같이 산정하며, 동 사용량을	○ ‘suxamethonium chloride 주사제(품

[일반원칙] 흡입마취에 사용되는 약제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유																														
	현 행	개 정(안)																															
흡입마취에 사용되는 약제	초과하여 투여하는 경우에는 투여소견서를 첨부하여야 함. - 아 래 - <table> <tr> <th>대상</th> <th>사용량</th> </tr> <tr> <td>Oxygen gas (품명: 산소)</td> <td>15분당 45ℓ (전신마취에 한함)</td> </tr> <tr> <td>Isoflurane (품명: 아이프란액 등)</td> <td>초회량: 15분까지 12.9ml, 유지량: 15분당 5.5ml</td> </tr> <tr> <td>Sevoflurane (품명: 세보레인흡입액 등)</td> <td>초회량: 15분까지 9.5ml, 유지량: 15분당 5ml</td> </tr> <tr> <td>Desflurane (품명: 슈프레인)</td> <td>초회량: 15분까지 15ml, 유지량: 15분당 10.7ml</td> </tr> <tr> <td>Thiopental sodium (품명: 펜토탈소듐)</td> <td rowspan="2">실제 사용량</td> </tr> <tr> <td>Suxamethonium chloride (품명: 석시콜린)</td> </tr> <tr> <td>Nitrous oxide (품명: 아산화질소)</td> <td>15분당 45ℓ (전신마취에 한함)</td> </tr> </table>	대상	사용량	Oxygen gas (품명: 산소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)	Isoflurane (품명: 아이프란액 등)	초회량: 15분까지 12.9ml, 유지량: 15분당 5.5ml	Sevoflurane (품명: 세보레인흡입액 등)	초회량: 15분까지 9.5ml, 유지량: 15분당 5ml	Desflurane (품명: 슈프레인)	초회량: 15분까지 15ml, 유지량: 15분당 10.7ml	Thiopental sodium (품명: 펜토탈소듐)	실제 사용량	Suxamethonium chloride (품명: 석시콜린)	Nitrous oxide (품명: 아산화질소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)	초과하여 투여하는 경우에는 투여소견서를 첨부하여야 함. - 아 래 - <table> <tr> <th>대상</th> <th>사용량</th> </tr> <tr> <td>Oxygen gas (품명: 산소)</td> <td>15분당 45ℓ (전신마취에 한함)</td> </tr> <tr> <td>Isoflurane (품명: 아이프란액 등)</td> <td>초회량: 15분까지 12.9ml, 유지량: 15분당 5.5ml</td> </tr> <tr> <td>Sevoflurane (품명: 세보레인흡입액 등)</td> <td>초회량: 15분까지 9.5ml, 유지량: 15분당 5ml</td> </tr> <tr> <td>Desflurane (품명: 슈프레인)</td> <td>초회량: 15분까지 15ml, 유지량: 15분당 10.7ml</td> </tr> <tr> <td>Thiopental sodium (품명: 펜토탈소듐)</td> <td rowspan="2">실제 사용량</td> </tr> <tr> <td>Suxamethonium chloride (품명: 석시콜린 등)</td> </tr> <tr> <td>Nitrous oxide (품명: 아산화질소)</td> <td>15분당 45ℓ (전신마취에 한함)</td> </tr> </table>	대상	사용량	Oxygen gas (품명: 산소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)	Isoflurane (품명: 아이프란액 등)	초회량: 15분까지 12.9ml, 유지량: 15분당 5.5ml	Sevoflurane (품명: 세보레인흡입액 등)	초회량: 15분까지 9.5ml, 유지량: 15분당 5ml	Desflurane (품명: 슈프레인)	초회량: 15분까지 15ml, 유지량: 15분당 10.7ml	Thiopental sodium (품명: 펜토탈소듐)	실제 사용량	Suxamethonium chloride (품명: 석시콜린 등)	Nitrous oxide (품명: 아산화질소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)	명: 타케다리스테논주)가 신규 등재 예정임에 따라, 이를 반영하여 해당 성분군의 품명에 ‘등’을 추가함.
대상	사용량																																
Oxygen gas (품명: 산소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)																																
Isoflurane (품명: 아이프란액 등)	초회량: 15분까지 12.9ml, 유지량: 15분당 5.5ml																																
Sevoflurane (품명: 세보레인흡입액 등)	초회량: 15분까지 9.5ml, 유지량: 15분당 5ml																																
Desflurane (품명: 슈프레인)	초회량: 15분까지 15ml, 유지량: 15분당 10.7ml																																
Thiopental sodium (품명: 펜토탈소듐)	실제 사용량																																
Suxamethonium chloride (품명: 석시콜린)																																	
Nitrous oxide (품명: 아산화질소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)																																
대상	사용량																																
Oxygen gas (품명: 산소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)																																
Isoflurane (품명: 아이프란액 등)	초회량: 15분까지 12.9ml, 유지량: 15분당 5.5ml																																
Sevoflurane (품명: 세보레인흡입액 등)	초회량: 15분까지 9.5ml, 유지량: 15분당 5ml																																
Desflurane (품명: 슈프레인)	초회량: 15분까지 15ml, 유지량: 15분당 10.7ml																																
Thiopental sodium (품명: 펜토탈소듐)	실제 사용량																																
Suxamethonium chloride (품명: 석시콜린 등)																																	
Nitrous oxide (품명: 아산화질소)	15분당 45ℓ (전신마취에 한함)																																

[일반원칙] 흡입마취에 사용되는 약제			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>			

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Dupilumab 주사제 (품명: 듀피젠티프리필드 주300밀리그램 등)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. (생 략) 2. 중증 제2형 염증성 천식 가.~다. (생 략)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. (현행과 같음) 2. 중증 제2형 염증성 천식 가.~다. (현행과 같음)	○ Mepolizumab(품명:누칼라주)과 다른 제형인 Mepolizumab(품명:누칼라오토인젝터주)이 등재됨에 따라, 동일 성분끼리의 교체투여를 인정하여 동일하게 변경함.

	라. 교체투여 1) 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(<u>mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 않음. 2) (생 략)	라. 교체투여 1) 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적제제(<u>mepolizumab, reslizumab, benralizumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 않음. 2) (현행과 같음)	
--	---	--	--

[219] 기타의 순환계용약

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
[219] 고혈압치료제 + 고지혈증 치료제	허가사항 범위 및 [일반원칙] 고지혈증 치료제 “세부사항” 범위 내에서 요양급여를 인정함. ※ 대상약제	허가사항 범위 및 [일반원칙] 고지혈증 치료제 “세부사항” 범위 내에서 요양급여를 인정함. ※ 대상약제	○ ‘fimasartan + atorvastatin calcium + ezetimibe(품명: 카나브젯정 60/20/10밀리그램

[219] 기타의 순환계용약

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
복합경구제	(생 략) · Amlodipine + Candesartan + Atorvastatin, · Amlodipine + Fimasartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Losartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Olmesartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Telmisartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Valsartan + Atorvastatin, · Amlodipine + Valsartan + Pitavastatin, · Amlodipine + Valsartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Atorvastatin calcium + Ezetimibe · Amlodipine + Rosuvastatin calcium + Ezetimibe <u><추 가></u> · Telmisartan + Rosuvastatin + Ezetimibe, (생 략)	(현행과 같음) · Amlodipine + Candesartan + Atorvastatin, · Amlodipine + Fimasartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Losartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Olmesartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Telmisartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Valsartan + Atorvastatin, · Amlodipine + Valsartan + Pitavastatin, · Amlodipine + Valsartan + Rosuvastatin, · Amlodipine + Atorvastatin calcium + Ezetimibe · Amlodipine + Rosuvastatin calcium + Ezetimibe · <u>fimasartan + Atorvastatin calcium + Ezetimibe</u> · Telmisartan + Rosuvastatin + Ezetimibe, (현행과 같음)	등)’ 4품목이 등재 예정임에 따라, 대상 약제에 해당 성분명을 추가함.

※ 관련근거

<요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>

[229] 기타의 호흡기관용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[229] Benralizumab 주사제 (품명: 파센라 프리필드시린지주 30밀리그램)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1.~3. (생 략) 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(<u>mepolizumab, benralizumab, reslizumab, dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. (생 략)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1.~3. (현행과 같음) 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(<u>mepolizumab, reslizumab, dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. (현행과 같음)	○ Mepolizumab(품명: 누칼라주)과 다른 제형인 Mepolizumab(품명: 누칼라오토티렉터주)이 등재됨에 따라, 동일 성분끼리의 교체투여를 인정하여 동일하게 변경함.

[229] 기타의 호흡기관용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[229] Mepolizumab 주사제 (품명: 누칼라주, 누칼라오토인젝터주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 ○ 성인 중증 호산구성 천식 환자 중 고용량의 흡입용 코르티코스테로이드-장기지속형 흡입용 베타2 작용제 (ICS-LABA)와 장기지속형 무스카린 길항제(LAMA)의 투여에도 불구하고 적절하게 조절이 되지 않는 경우로서 다음 1), 2) 조건 중 하나에 해당하는 경우 ※ I C S - L A B A : I n h a l e d CorticoSteroids-Long Acting Beta-2	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. <u>투여대상 중 가. 또는 나. 에 해당하면서 다음 1), 2) 조건 중 하나에 해당하는 경우</u> <u>가. 누칼라주</u> ○ <u>성인 중증 호산구성 천식 환자 중 고용량의 흡입용 코르티코스테로이드-장기지속형 흡입용 베타2 작용제 (ICS-LABA)와 장기지속형 무스카린 길항제(LAMA)의 투여에도 불구하고 적절하게 조절이 되지 않</u>	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여, ‘누칼라오토인젝터주’가 등재 예정임에 따라 제형이 다른 점을 고려하여 품명을 추가하고 장기처방 관련 기준을 추가함.

	AgonistLAMA: Long Acting Muscarinic Antagonist - 다 음 - 1) 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 수치가 300 cells/μl 이상이면서 - 치료 시작 전 12개월 이내에 전신 코르티코스테로이드가 요구되는 천식 급성악화가 4번 이상 발생하였거나, 치료 시작 6개월 전부터 prednisolone 5mg/day 와 동등한	<u>는 경우</u> 나. <u>누칼라오토인젝터주</u> ○ <u>12세 이상 중증 호산구성 천식 환자 중 고용량의 흡입용 코르티코스테로이드-장기지속형 흡입용 베타2 작용제 (ICS-LABA)와 장기지속형 무스카린 길항제(LAMA)의 투여에도 불구하고 적절하게 조절이 되지 않는 경우</u> ※ICS-LABA:Inhaled CorticoSteroids-Long Acting Beta-2 AgonistLAMA: Long Acting Muscarinic Antagonist - 다 음 - 1) 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 수치가 300cells/μl 이상이면서 - 치료 시작 전 12개월 이내에 전신 코르티코스테로이드가 요구되는 천식 급성 악화가 4번 이상 발생하였거나, 치료 시작 6개월 전부터 prednisolone 5mg/day 와 동등한	
--	---	--	--

	수준 이상의 경구용 코르티코스테로이드를 지속적으로 투여한 경우 2) 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 수치가 400 cells/μl 이상 이면서 - 치료 시작 전 12개월 이내에 전신 코르티코스테로이드가 요구되는 천식 급성악화가 3번 이상 발생한 경우 2.~3. (생략) 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(<u>mepolizumab</u>, <u>reslizumab</u>, <u>benralizumab</u>, <u>dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. omalizumab 주사제 투여 후 동 약제로의 교체투여는 다음의 조건을 모두 만족하면서 투여소견서 첨부 시 사례별로 급여 인정함.	수준 이상의 경구용 코르티코스테로이드를 지속적으로 투여한 경우 2) 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 수치가 400cells/μl 이상 이면서 - 치료 시작 전 12개월 이내에 전신 코르티코스테로이드가 요구되는 천식 급성악화가 3번 이상 발생한 경우 2.~3. (현행과 같음) 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(<u>reslizumab</u>, <u>benralizumab</u>, <u>dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. omalizumab 주사제 투여 후 동 약제로의 교체투여는 다음의 조건을 모두 만족하면서 투여소견서 첨부 시 사례별로 급여 인정함.	
--	--	---	--

	- 다 음 - 1) omalizumab 주사제를 3-6개월 이상 사용하였음에도 효과가 불충분하거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 2) 동 약제의 투여대상 조건을 만족하는 경우 5. <신 설> 6. <신 설>	- 다 음 - 1) omalizumab 주사제를 3-6개월 이상 사용하였음에도 효과가 불충분하거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 2) 동 약제의 투여대상 조건을 만족하는 경우 5. <u>‘누칼라오토인젝터주’가 자가주사제인 점을 고려하여, 동 약제의 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함.</u> 6. <u>‘누칼라오토인젝터주’의 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 8~12주분까지로 하며 원내·외 처방 가능함. 다만, 최초 투약일로부터 6개월 이후에 안정된 질병 활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 24주분까지 인정함.</u>	
※ 관련근거			

- Nelson Textbook of Pediatrics (2024)
- Global strategy for Asthma Management and prevent (2025)
- Management of severe asthma:a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline (2020)
- Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma (MENSA study) N Engl J Med 2014;371:1198-207.
- Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Mepolizumab in Eosinophilic Asthma(SIRIUS study) N Engl J Med 2014;371:1189-97
- Efficacy of mepolizumab add-on therapy on health-related quality of life and markers of asthma control in severe eosinophilic asthma (MUSCA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentre, phase 3b trial. Lancet Respir Med 2017; 5: 390-400.
- Long-term Safety and Clinical Benefit of Mepolizumab in Patients With the Most Severe Eosinophilic Asthma: The COSMEX Study. Clinical Therapeutics, 41(10), 2041-2056
- 대한천식알레르기학회(대알학 2025-123호, 2025.10.22.)
- 대한결핵 및 호흡기학회(결학 2025-526호, 2025.11.07.)
- NICE (2021.02.03.)
- SMC (2025.04.04.)
- PBAC(2024.03)
- CDA-AMC(2019.03.27.)

[229] Reslizumab 주사제 (품명: 싱케어주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1.~3. (생 략)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1.~3. (현행과 같음)	○ Mepolizumab(품명:누칼라주)과 다른 제형인 Mepolizumab(품명:누칼라오토인젝터주)이 등재됨에 따라, 동일 성분끼리의 교체투
---	---	--	--

	4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(<u>mepolizumab, benralizumab, reslizumab, dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 않음. 나. (생략)	4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(<u>mepolizumab, benralizumab, dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 않음. 나. (현행과 같음)	여를 인정하여 동일하게 변경함.
--	--	--	--------------------------

[232] 소화성 궤양용제			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현행	개정(안)	
[232] Sulglycotide 경구제 (품명: 클립타이드정)	허가사항 범위 내에서 '위·십이지장염'에 투여시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	<삭제>	○ '설글리코타이드' 성분 약제에 대해 식품의약품안전처에서 임상재평가 실시 결과 유용성을 입증하지 못하여

[232] 소화성 궤양용제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
200밀리그램)			급여 중지 됨에 따라 이를 반영하여 급여기준을 삭제함
※ 관련근거 · 식품의약품안전처 의약품안전평가과-1766호(2026.3.13.)			

[241] 뇌하수체호르몬제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
[241] Somatrogen 주사제 (성장호르몬제) (품명: 엔젤라프리필드펜주 24mg 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상, 용량 및 기간 1) 소아성장호르몬결핍증 (생 략) <u>나.</u> 장기투여원칙 성장호르몬제를 6개월간 투여해도 별 반응이 없는 환자에 대해서는	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상, 용량 및 기간 1) 소아성장호르몬결핍증 (현행과 같음) <u>2.</u> 장기투여원칙 성장호르몬제를 6개월간 투여해도 별 반응이 없는 환자에 대해서는 진료	○ 급여기준 명확화 위해 문구 정비

[241] 뇌하수체호르몬제

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	진료담당 의사는 성장호르몬제 투여의 적정성에 대해 재검토해야 함 <u>다.</u> 성장호르몬제를 투여할 수 있는 요양기관 조건 (생 략) <u>라.</u> 성장호르몬제는 자가주사로 처방 가능함 <u>2.</u> 허가사항 범위를 초과하여 「보조생식술 급여 기준」에 투여하는 경우에는 “[일반원칙] 보조생식술에 사용되는 호르몬 약제”에 의거하여 인정함.	담당 의사는 성장호르몬제 투여의 적정성에 대해 재검토해야 함 <u>3.</u> 성장호르몬제를 투여할 수 있는 요양기관 조건 (현행과 같음) <u>4.</u> 성장호르몬제는 자가주사로 처방 가능함 <u>5.</u> 허가사항 범위를 초과하여 「보조생식술 급여 기준」에 투여하는 경우에는 “[일반원칙] 보조생식술에 사용되는 호르몬 약제”에 의거하여 인정함.	
※ 관련근거 급여기준 명확화 위해 문구 정비			